

PSICOPATOLOGÍA GENERAL

INTRODUCCIÓN · § 3. PREJUICIOS Y PRESUPOSICIONES (TEXTO ÍNTEGRO Y LITERAL)

Autor: Karl Jaspers (1913). Traducción de la 5.ª edición alemana (1946) por el Dr. Roberto O. Saubidet y Diego A. Santillán.

Fuente: *Psicopatología General*, Introducción (§ 3, pp. 31-39). Buenos Aires: Editorial Beta, 1966.

Asignación académica: Clase 3 — El síntoma y la causalidad (Psicopatología I · UFLO Online 2026)

§ 3. PREJUICIOS Y PRESUPOSICIONES

Allí donde aprehendemos algo, hemos aportado ya lo que hace posible y forma nuestra aprehensión. Si nuestra aprehensión es falseada de ese modo, hablamos de *prejuicios*; si nuestra aprehensión es fomentada e inspirada, hablamos de *presuposiciones* o *hipótesis*.

a) Prejuicios

Un procedimiento ilustrativo de nuestro autoconocimiento crítico consiste en hacer consciente lo que habíamos pensado inconscientemente como algo natural por sí mismo. Fuentes de los prejuicios son, entre otras: el impulso a la concepción unitaria del todo, que podría darse por satisfecha con nociones básicas simples y conclusivas; además, por eso, la inclinación a la generalización o a dar carácter absoluto a puntos de vista particulares, a métodos, a categorías; además, a la confusión entre posibilidad de saber y convicción de fe.

Los prejuicios pesan en nosotros inconscientemente, sin embargo, como una presión paralizante. Una tarea esencial en todos los capítulos consistirá en resolverlos. Caracterizamos más adelante algunos en una forma llevada al extremo. Conocidos así, son advertidos también en los esbozos en que se nos presentan a menudo.

1. Prejuicios filosóficos

Hubo tiempos en que la especulación, el pensamiento deductivo de un principio, que se quería reconocer y explicar sin mucha experiencia, era apreciado más altamente que la investigación laboriosa de detalles; tiempos en los que la filosofía quería producir «desde arriba» lo que sólo podía dar la experiencia «desde abajo». Actualmente esa tendencia parece liquidada por entero, pero todavía se agita aquí y allá en construcciones embrolladas, oscuras. Su espíritu está envuelto en la sistematización usual de la psicopatología general, pero es claramente reconocible. Al justificado rechazo de la construcción filosófica meramente deductiva, infecunda, se une por desgracia a menudo el otro prejuicio, el que imagina que sólo la recolección de experiencias particulares tiene justificación, que el ciego amontonamiento es mejor que el pensamiento. El pensamiento, que clasifica los hechos, que proporciona un plan del trabajo, que crea concepciones de conjunto y hace posible una investigación apasionada de los objetos científicos fecundos, ha perdido mucho la estimación general.

La actitud filosófica deductiva se unió mayormente con valoraciones éticas y otras, con una tendencia moralizadora y teológica, habló de pecados y de pasiones, a través de los cuales surgían las enfermedades mentales, y dividió las cualidades humanas en buenas y malas. Maximilian Jacobi ha criticado aniquiladoramente en sus escritos, en la primera parte del siglo XIX, esa «filosofía en falso lugar». Si dicha filosofía de la cosmovisión como expresión de la actitud humana ante el mundo tiene la mayor significación, en la ciencia no tiene lugar. Entre concepciones del mundo se da a menudo sólo la lucha sin discusión por el poder: entre las opiniones científicas, en cambio, es posible siempre la discusión y la convicción. La psicología y psicopatología difícilmente se mantienen libres de valoraciones que son expresión de una concepción del mundo, pero la separación entre conocer y valorar debe estimularse por todo psicopatólogo. No es que se le deba rehusar como hombre el valorar, al contrario: pero juzgará tanto más veraz, clara y hondamente cuanto mejor haya conocido antes. Necesita una tranquila inmersión en los hechos de la vida del alma, sin tomar posición en seguida; debe

poder aproximarse a los individuos libremente, con interés incondicionado y sin prejuizar. Esa separación del conocer y del valorar es en verdad fácilmente comprensible en principio, pero exige en la realización una medida tan alta de autocrítica y de objetividad que está todavía lejos de ser algo espontáneo y natural.

2. Prejuicio teórico

Las ciencias naturales se apoyan en amplias teorías bien fundadas, que dan un fundamento unitario a la interpretación de los hechos. La teoría de los átomos y la teoría celular son tales. En la psicología y la psicopatología no hay ninguna de esas teorías dominantes. En estas ciencias no es posible, por tanto, ningún sistema teórico unitario —o lo es sólo como construcción personal—. En lugar de llegar a los elementos, mecanismos y reglas últimos, por los que se comprende todo lo psíquico o tiene que ser comprendido un día, avanzamos por caminos especiales, trabajamos según métodos singulares, que nos muestran aspectos aislados de la vida del alma. Esta misma se nos presenta no sólo como un todo infinito, sino también como un todo que se resiste a la sistematización lógica, como un océano que recorreremos junto a las costas y de tanto en tanto por alta mar, pero sólo por la superficie.

Atribuir la vida del alma a algunos principios universales y dominarla por decirlo así en principio, es falso en el planteamiento, porque es imposible. Lo que aprovechamos como pensamientos teóricos, que tienen un parentesco formal con las teorías científiconaturales, son intentos (hipótesis) para fines especiales limitados del conocimiento, no para el conocimiento del alma en su totalidad.

Donde impera un prejuicio teórico, influirá en la aprehensión de los hechos típicos. Se ven los hallazgos siempre en el esquema de la teoría. Lo que se aplica a ella y la confirma, interesa. Lo que no tiene ninguna relación con ella, no es en modo alguno percibido. Lo que habla contra ella, es velado o interpretado de otro modo. La realidad es vista por los anteojos de la teoría. Por eso es nuestra tarea ejercitarnos constantemente en aprehender puramente los hallazgos, haciendo abstracción de los prejuicios teóricos que pesan en todo instante sobre nosotros. Pero como todo hallazgo sólo es perceptible en virtud de determinadas categorías y métodos, esto hay que hacerlo consciente en toda comprobación de la naturaleza de las cosas, según lo establecido antes, que «en todo hecho está ya la teoría». Aprendemos a ver así las realidades y a saber que no son en parte alguna la realidad en sí, que no son en parte alguna toda la realidad.

3. Prejuicio somático

Se admite tácitamente que la verdadera realidad del hombre como todo lo biológico es un acontecer somático. Es reconocido el hombre donde es reconocido somáticamente; hablar de lo psíquico es provisorio y significa sólo un sucedáneo sin verdadero valor de conocimiento. Por eso se propende a discutir todo lo psíquico como si se tuviese en la mano ya la cosa lo mismo que lo somático, o como si los pensamientos actuales estuviesen en el camino de un descubrimiento somático inminente. Mientras que la legítima investigación sólo hace esbozos, que dan simultáneamente motivo a investigaciones reales, a verificaciones o refutaciones por los hallazgos somáticos, se da aquí validez a la mera fantasía como una supuesta anticipación heurística, que en los hechos, sin embargo, sólo es la manifestación detallada del prejuicio sin valor de conocimiento. O al menos se mantiene el prejuicio en la forma de disposición resignada en toda la consideración psicológica, por ejemplo en la opinión de que todo interés psicológico por la esquizofrenia se extinguirá en el momento en que se haya conocido el proceso somático de la enfermedad que constituye su cimiento.

El prejuicio somático vuelve siempre, tanto si se disfraza en lo sucesivo más fisiológica o anatómicamente, o, sin precisión, biológicamente. Al comienzo de este siglo se decía más o menos: lo psíquico como tal no se puede investigar, es solamente subjetivo. En tanto que se puede hablar de ello científicamente, tiene que ser presentado anatómicamente, físicamente, como función corporal; por eso es mejor poseer una construcción anatómica provisoria que una mera investigación psicológica. Pero tales construcciones anatómicas han sido enteramente fantásticas (Meynert, Wernicke) y son llamadas con razón «mitologías del cerebro». Son asociadas cosas que no tienen entre sí ninguna relación, como

células de la corteza e imágenes mnemónicas, haces cerebrales y asociaciones psicológicas. Falta a esas construcciones somáticas todo fundamento en tanto que no es conocido un solo proceso cerebral preciso al que esté subordinado un determinado proceso psíquico como fenómeno paralelo directo. La localización de los diversos campos sensoriales en la corteza cerebral, de las afasias en el hemisferio izquierdo, significan sólo que esos órganos tienen que quedar intactos para que sea posible un determinado proceso psíquico; sin embargo, en principio no distintamente a los mecanismos motores, etc., como instrumentos necesarios para el funcionamiento intacto del ojo. Se ha ido más allá en los mecanismos neurológicos, pero se está infinitamente lejos de los fenómenos que irían paralelamente con lo psíquico. Se ha admitido del todo erróneamente que se ha echado pie firme en el reino de lo psíquico con el descubrimiento de las afasias y apraxias.

El problema de saber si lo psíquico y lo corporal están en paralelismo o en relación mutua, no se puede decidir, por tanto, empíricamente. No conocemos un solo caso en que sea posible comprobar empíricamente lo uno o lo otro. Lo psíquico y los fenómenos corporales que nos son accesibles —en tanto que ambos se convierten en objetos explorables— están separados por un infinito ámbito de sucesos intermedios que no conocemos. Podemos hablar en la práctica tanto en el lenguaje del paralelismo como en el de la acción recíproca —en verdad mayormente en el último—. Y lo podemos hacer tanto más cuanto que en todo momento se logra traducir un modo de expresión al otro. Pero por lo que se refiere a la tendencia a traducir lo psicológico en procesos somáticos de naturaleza fantástica o real, se aplica con derecho lo que dice Janet: *Si hay que pensar siempre anatómicamente, hay que resignarse y no pensar nada cuando se trata de psiquiatría.*

4. Prejuicio psicológico e intelectualista

De la comprensión empática se desarrolla no raramente un prejuicio psicológico. Se quiere «comprender» todo y se pierde el sentido crítico de las fronteras de lo psicológicamente comprensible. Esto ocurre cuando es aplicada la psicología comprensiva como explicación causal con la presuposición de la determinación universal significativa de toda vivencia. Pero especialmente se inclinan a eso los no expertos en psicología y los de predisposición somática. Así la mala voluntad, el querer esquivar el peligro, son hechos responsables de muchas cosas. Tal interpretación no se basa finalmente en la psicología, sino en prejuicios moralistas no aclarados. Algunos médicos somáticos tienen una repulsión manifiesta contra lo histérico, están en su interior irritados cuando no pueden hallar físicamente nada de acuerdo con las categorías usuales para ellos. Lo consideran todo entonces como una maldad y sólo cuando se llega a ciertos extremos entregan el caso al psiquiatra. La tosquedad y la simplicidad de lo psicológico se encuentra justamente en los médicos que no quieren saber nada de psicología.

En la vida psíquica hay relaciones en que alguien, consciente del objetivo, obra por motivos racionales. Ahora bien, existe una difundida propensión a admitir «razones» conscientes como motivo de toda acción en los hombres. En realidad esas relaciones racionalmente comprensibles en la vida psíquica humana juegan sólo un papel mínimo. Los impulsos irracionales y los estados de ánimo suelen imperar también allí donde el individuo quiere creer que obra por motivos conscientes racionales. La exageración en la búsqueda de relaciones racionales, esa «psicología intelectualista», es un obstáculo para la penetración comprensiva en las relaciones del actuar humano. Se sobreestiman los efectos de la prueba lógica frente a las persuasiones sugestivas, se corre demasiado al hablar de «demencia» donde se halla lo irracional y no se obtiene ninguna concepción de la riqueza infinita de la vivencia humana.

5. Prejuicio representativo

Lo anímico se nos vuelve objetivo en la expresión y la obra, en la conducta y la acción, en el proceso somático y en las manifestaciones del lenguaje. Pero lo anímico mismo no lo podemos actualizar objetivamente fuera de la imagen y la comparación. Lo experimentamos y realizamos, lo imaginamos, pero no lo vemos. Cuando hablamos de lo anímico hablamos siempre en imágenes, mayormente en imágenes espaciales. Así se aplican en el pensamiento psicológico, por decirlo así, diseños del alma y eso de diversa naturaleza: la vida psíquica es una corriente de la conciencia. La conciencia es como un espacio en el que todos los fenómenos psíquicos, como figuras en un escenario, van y vienen. El espacio se

pierde en lo infinito hacia lo inconsciente. El alma es edificada en estratos, en estratos de la conciencia, de la vivencia, de las funciones del carácter. Se compone de elementos que se asocian y se combinan alternativamente. Es movida por fuerzas básicas, disoluble en factores o componentes, se le puede describir como una cosa por las cualidades. No podemos prescindir de estas y aquellas representaciones espaciales como elementos auxiliares. No harán daño, si no probamos nada por su intermedio, sino que sólo queremos hacer más fácilmente accesible lo hallado sin eso. Ha ocurrido con frecuencia, sin embargo, que la imagen es olvidada como imagen y tomada como construcción válida, que se apoderó de toda la vida psíquica y la convirtió en prejuicio. Cuanto más inteligibles eran las imágenes y más despertaron al mismo tiempo la apariencia de una exposición completa, tanto más dominaron las cabezas. Así han significado la disolución de lo psíquico en elementos atómicos, la representación del funcionamiento por analogía con el movimiento de los corpúsculos (mecánica de la representación) o de las asociaciones psicológicas según la analogía de las combinaciones químicas (química psíquica), y a veces no por imágenes y comparaciones, sino por representaciones que responden realmente a la cosa. Se está también propenso siempre por lo demás a hacer de las imágenes «prejuicios representativos».

6. Prejuicios médicos en relación con lo cuantitativo, con la perceptibilidad y el diagnóstico

De las ciencias naturales exactas llega el prejuicio de que sólo las comprobaciones cuantitativas son trabajos científicos, que la investigación de lo solamente cualitativo en cambio es siempre subjetivo y arbitrario. Los métodos estadísticos y experimentales, que realizan algo acerca de ciertos problemas por mediciones, recuentos, formaciones de curvas, son en esta opinión la única investigación científica. Donde tal investigación directa no es posible, se trabaja aún con conceptos cuantitativos, aun cuando no se puede pensar más en ellos. Así, por ejemplo, en construcciones seriamente pensadas en el curso del tiempo, la «intensidad» de la representación es hecha causa de representaciones obsesivas, causa de fenómenos histéricos, causa de ideas delirantes y causa de errores sensoriales, en tanto que la representación muy intensa «es proyectada hacia fuera».

Se quería hacer valer sólo lo perceptible por los sentidos como objeto de investigación. Las investigaciones de los fenómenos corporales, de los rendimientos y de los productos son en verdad muy valiosas. Pero, no obstante, se puede penetrar en lo psicológico siempre si se imagina directamente lo psicológico, que es especialmente cualitativo. Lo psicológico no es perceptible nunca sensorialmente de modo directo, lo es en la expresión. Tal evidencia implica que toda psicopatología que quiera sólo atenerse a lo perceptible por los sentidos, ha de ser necesariamente una psicología sin lo propiamente psíquico.

El diagnóstico es lo último en la interpretación psiquiátrica de un caso. Pero aparte del diagnóstico de los conocidos procesos del cerebro, es lo menos esencial en el trabajo realmente psicopatológico. Convertido en lo principal, se vuelve una anticipación de algo que está al fin ideal de la investigación. Importa al análisis que el caos de los fenómenos no sea un obstáculo para el conocimiento con un nombre diagnóstico, sino que se vuelva transparente por visión panorámica y en un encadenamiento de diversa naturaleza. Diagnosticar es en psiquiatría a menudo un estéril girar en círculo, con lo cual sólo muy pocos fenómenos caen en el campo visual del saber consciente.

b) Presuposiciones

Frente a los prejuicios hay que mantener la misión de reconocer la realidad de la vida psíquica con todos los medios y desde todos los lados. El impulso a la realidad, que es propio de todo investigador en la ciencia empírica, exige en las partes somáticas de la psiquiatría comprobaciones histológicas, neurológicas, y rechaza las construcciones y los pensamientos anatómicos sobre meras posibilidades. En psicopatología el fundamento real de nuestra investigación es la vida psíquica comprendida, la que se nos hace presente por el comportamiento sensorialmente percibido y a través de las manifestaciones habladas. Queremos sentir, comprender, meditar lo que pasa realmente en el alma de los hombres. El impulso general hacia la realidad es en psicopatología el impulso hacia la vida psíquica real, que queremos reconocer en parte como objetos científico-naturales perceptibles por los sentidos. Rehusamos discutir esa vida psíquica real, cuya

comprensión nos da la plenitud de nuestros conceptos a través de ideas vacías provenientes de prejuicios, o hacer sustituir aquella por construcciones anatómicas o de otra especie. Sin la capacidad y el placer de imaginar lo psicológico en su plenitud, no hay posibilidad alguna de hacer psicopatología.

Pero el investigador no es investigador como una mera razón que sería una forma vacía, en la que se resumiría lo aprehensible desde fuera. Más bien el investigador, con toda su vivacidad, es el instrumento indispensable de su conocer. En él tiene que haber presuposiciones, sin las cuales sería estéril su investigación. Tenemos que esclarecer los prejuicios para librarnos de ellos, pero las hipótesis necesarias tenemos que comprenderlas: o bien son rudimentos objetivos del pensamiento que tenemos que hacer por vía de ensayo; o son fundamentos en nosotros mismos, movimientos de los contenidos del propio ser, sin los cuales no podemos ver nada esencial; tales hipótesis o presuposiciones son las ideas dirigentes, el alma y la existencia del investigador; esas hipótesis deben ser ahondadas, hay que tratar de iluminarlas; hay que admitirlas. No son nunca motivos de la exactitud de una opinión, sino origen de su verdad y esencialidad.

Los falsos prejuicios son hipótesis al fin fijadas, que pasan falsamente por absolutas, apenas advertidas y no conscientes, y son disueltas por la aclaración. Hipótesis legítimas están en el investigador como condiciones de su capacidad de ver y comprender; son admitidas propiamente por medio del esclarecimiento.

Lo más característico que reconoce el psicopatólogo se da en el trato con seres humanos. Lo que experimenta así es dependiente de cómo se da la situación al hombre y cómo colabora terapéuticamente a su producción, iluminándose al mismo tiempo él mismo y los otros. No opera sólo una percepción indiferente, como al leer una medida, sino una comprensión abarcativa en la visión del alma.

Hay una especie de presencia en el interior de los otros seres humanos, en una tentativa de transformarse uno mismo en un teatralismo, el cual, por decirlo así, es inspirado por substancia; hay una espontaneidad en la actitud que se entrega y escucha sin desviación del motivo. El psicopatólogo es dependiente de su capacidad de visión y de experimentación, de su amplitud, de su franqueza y plenitud. Hay una gran diferencia entre los hombres que andan ciegos por el mundo de los enfermos a pesar de los ojos abiertos, y la distinción que establece una percepción clara en una sensibilidad activa.

El estremecimiento del alma propia con los acontecimientos en otros favorece en el investigador la objetivación pensante de tal experiencia. La conmoción no es todavía conocimiento, sino fuente de las concepciones que proporcionan el material ineludible para el conocimiento. La frialdad y el estremecimiento marchan juntos y no se pueden oponer la una al otro. La fría observación por sí sola no ve nada esencial. Sólo ambos pueden llevar al conocimiento en el intercambio mutuo. El psicopatólogo que ve realmente, es un alma en vibración que domina constantemente lo visto, llevándolo a una forma racional.

La crítica de los fundamentos del conocimiento en la propia esencia se pregunta frente a los objetos: *¿En qué disposición los interpreto? ¿Han adquirido falso o legítimo rango en la esencia y peso para la interpretación de la realidad? ¿Qué saco de ellos? ¿Cómo actúan en mi conciencia?* Un trabajo en la esencia de uno mismo es necesario para el que reconoce. Tan sólo un conocer en el que se identifica el que conoce, es un pleno conocer; ese conocer puede elevarse, no sólo extenderse niveladoramente.

El investigador y el médico tienen que conquistar un mundo interior de concepciones. Un recuerdo de las imágenes vistas, de los estados morbosos concretos, de las visiones biológicas totales, de los comportamientos esenciales, en una palabra su experiencia histórica personal tiene que estar a su disposición como objeto de comparación. Además una comprensión estructurada debe hacerle posible la clara interpretación de lo que quiere.